

What to expect after cataract surgery

Right after surgery, you should stay in the recovery area for a short time. Your eye doctor should give you an identification card (typically called implant card) to keep in your wallet. This card shows the type of implant in your eye. Present this card to any eye doctor who examines your eyes after surgery.

Many patients may begin to see better within 1 to 2 days. Some are stable at 10 to 14 days. Some may take 4 to 6 weeks to recover from surgery. Improvements in vision are different for each person.

Call your eye doctor right away if you experience any itching, pain, flashing lights, "floaters", redness, severe headache, nausea/vomiting, light sensitivity, or watery eyes after surgery.

Instrutions for post-operative care

You will be allowed to return home on the same day after surgery. Your eye doctor will give you antibiotic eye drops and medicines to speed up healing and to prevent infection. Take all prescribed medicines and apply eye drops as instructed by your eye doctor.

For the first week after surgery, do not go swimming or use a bath or hot tub to help prevent infection. Also try to protect your eye from things like dirt, dust, and strong wind. Keep the eyes protected with sunglasses as much as possible and sleep with your eye shield at night. You should avoid rubbing your eye or putting extra pressure on it. You will be given a date and time for a follow-up visit. It is typically the next day. Your doctor will examine you several more times following your surgery depending on the speed of healing. It may take you some time to get used to new IOL.

Talk to your eye doctor if you have any questions or concerns after surgery.

Undesirable side effects, warnings and residual risk

■ Visual light phenomena

After cataract surgery, some patients may notice glare or halos, especially in low light. Halos appear as bright rings around lights, while glare is bright light that can affect clear vision. These effects may be more noticeable when driving at night or looking at artificial lights. In most cases, these effects improve within a few weeks or months as the brain adapts to the intraocular lens. If they continue after healing, consult your ophthalmologist. Always follow your surgeon's instructions and report any unusual symptoms.

■ Decentration or deviating dioptr power of the lens:

In rare cases, the implanted lens may move slightly from its position in the eye, even years after surgery. This can cause visual disturbances or glare, which can usually be corrected with a surgical procedure.

Sometimes the lens power may not perfectly match the eye, which can affect vision. This may happen if the lens does not settle exactly as predicted or due to small calculation differences. In most cases, the effect is minor. If the difference is larger, it can usually be corrected with glasses, contact lens, lasik or surgery.

Inform your doctor if you experience:

- a strong pain in your eye
- recurring redness of the eye
- unusual headache or nausea
- considerable vision deterioration
- light flashes, or huge increase of floaters in your eye

These are rare complications that may occur shortly after surgery.

■ Infections and minor complications

As with any surgery, there is a small risk of infection after cataract surgery, although serious complications are rare. If an infection occurs, it can usually be treated with prescribed eye drops. You should contact your ophthalmologist if your eye becomes swollen or if you notice any unusual symptoms.

Some minor complications may include:

- Swelling
- Increased pressure in the eye
- Droopy eyelid

These conditions are usually temporary and improve with medication and proper healing. Inform your ophthalmologist immediately if you notice any changes so your recovery can be monitored and treated if needed.

■ Posterior capsule opacification

Posterior capsule opacification (PCO) is a common condition that may occur after cataract surgery. It happens when some remaining lens cells grow on the thin membrane behind the implanted lens, causing vision to become cloudy again. Although it is sometimes called a "secondary cataract," it is not a new cataract.

PCO can be easily treated with a quick and painless ND-YAG laser procedure performed by your ophthalmologist. The treatment usually takes only a few minutes, and most patients notice improved vision within a day. If your vision becomes blurry again after surgery, contact your ophthalmologist for further advice.

Magnetic Resonance Compatibility:

The implanted IOL does not contain any metallic components and are safe with no potential for interaction with the Magnetic Resonance (MR) Field. IOL is safer for Magnet Resonance Imaging (MRI) at a magnetic field strength of 1.5 and 3.0 Tesla.

Expected lifetime and necessary follow-up

The IOL will usually last for a patient's lifetime. Should you however encounter any deterioration in your vision quality, please consult your eye doctor for further investigation and treatment. Your eye doctor will discuss with you about the necessary follow-up intervals based on your medical condition.

Reporting of serious incidents

Any serious incident that occurs in relation to the intraocular lens should be reported to your doctor (in the first instance), to the local representative or to the EYEOL U.K. LIMITED.

About this document:

Your ophthalmologist has performed the cataract surgery and implanted the intraocular lenses (IOL) in your eye. The patient implant card and leaflet have been given to you after the cataract surgery. Please always carry the patient implant card with you to facilitate medical care in case of emergency. The link provided on the implant card will provide you latest updates about the IOL.

 EYEOL U.K. LIMITED 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LUS 45B, UK Tel: +44 (0) 1582 477 002 Fax: +44 (0) 1582 607 009 Email: info@eyeol.co.uk Web: www.eyeol.co.uk	 European Representative OEBELIS S.A Bd. Général Wahnis, 53 1030 Bruxelles, Belgium Tel: +32.2.732.59.54 Fax: +32.2.732.60.03 Email: mail@oebelis.net Web: www.oebelis.net	 2460
--	---	---

À quoi s'attendre pendant la chirurgie de la cataracte

La chirurgie de la cataracte est généralement réalisée en ambulatoire. Une anesthésie sous forme d'injection oculaire sera administrée afin d'insensibiliser votre œil. En règle générale, vous resterez pleinement éveillé pendant l'intervention. Vous ne devriez ressentir que peu ou pas d'inconfort. Votre ophthalmologiste utilisera un microscopie afin d'obtenir une vue agrandie de votre œil. Votre cristallin naturel est situé dans une structure en forme de sac appelée capsule cristalliniennne. La capsule cristalliniennne se trouve juste derrière la partie colorée de l'œil (l'iris). Une petite incision est pratiquée à la surface externe de l'œil. L'ophthalmologiste introduit une minuscule sonde à travers cette ouverture afin de fragmenter le cristallin cataracté. Il utilise ensuite un petit dispositif d'aspiration pour retirer les fragments de cataracte de votre œil. Un espace est alors disponible pour l'implantation de la LIO dans votre œil, afin de remplacer le cristallin naturel. Votre ophthalmologiste vient de retirer. Votre médecin introduira la LIO à travers la même petite incision. Une fois l'intervention terminée, votre ophthalmologiste pourra placer un pansement ou une coque de protection sur votre œil.

À quoi s'attendre après la chirurgie de la cataracte

Immédiatement après l'intervention, vous devriez rester quelque temps dans la zone de récupération. Votre ophthalmologiste devra vous remettre une carte d'identification (généralement appelée carte d'implant) à conserver dans votre portefeuille. Cette carte note le type d'implant présent dans votre œil. Présentez cette carte à tout ophthalmologiste qui examinera vos yeux après l'intervention.

De nombreux patients commencent à mieux voir dans un délai de 1 à 2 jours. Chez certains, la vision se stabilise au bout de 10 à 14 jours. D'autres peuvent nécessiter 4 à 6 semaines pour récupérer complètement après l'intervention. L'amélioration de la vision varie d'une personne à l'autre.

Contactez immédiatement votre ophthalmologiste si vous ressentez des dérangements, des douleurs, des éclairs lumineux, des « corps flottants », une rougeur, de forts maux de tête, des nausées/vomissements, une sensibilité à la lumière ou un larmoiement après l'intervention.

Instrutions relatives aux soins postopératoires

Vous pourrez rentrer chez vous le jour même de l'intervention. Votre ophthalmologiste vous prescrira des collyres antibiotiques et des médicaments destinés à accélérer la cicatrisation et à prévenir les infections. Prenez tous les médicaments prescrits et appliquez les collyres conformément aux instructions de votre ophthalmologiste.

Pendant la première semaine suivant l'intervention, évitez de nager ainsi que l'utilisation d'une baignoire ou d'un bain à remous afin de prévenir les infections. Essayez également de protéger votre œil de la saleté, de la poussière et des vents forts. Gardez vos yeux protégés avec des lunettes de soleil autant que possible et portez votre coque de protection oculaire pendant la nuit. Vous devez éviter de vous frotter l'œil ou d'exercer une pression supplémentaire sur celui-ci. Une date et une heure vous seront communiquées pour une visite de suivi, généralement le lendemain de l'intervention. Votre médecin vous examinera plusieurs fois après l'opération en fonction de la vitesse de cicatrisation. Il peut vous falloir un certain temps pour vous habituer à votre nouvelle LIO.

Parlez à votre ophthalmologiste si vous avez des questions ou des préoccupations après l'intervention.

Effets indésirables, avertissements et risques résiduels

■ Phénomènes lumineux visuels

Après une chirurgie de la cataracte, certains patients peuvent remarquer des éblouissements ou des halos, particulièrement dans des conditions de faible luminosité. Les halos apparaissent sous forme d'anneaux lumineux autour des sources de lumière, tandis que l'éblouissement correspond à une lumière intense pouvant altérer la qualité de la vision. Ces effets peuvent être plus perceptibles lors de la conduite de nuit ou lors de l'observation de lumières artificielles.

Dans la plupart des cas, ces effets s'atténuent au bout de quelques semaines ou de quelques mois à mesure que le cerveau s'adapte à la nouvelle configuration. Si des phénomènes persistent après la période de cicatrisation, consultez votre ophthalmologiste. Suivez toujours les instructions de votre chirurgien et signalez tout symptôme inhabituel.

■ Décentrement ou puissance dioptrique inadéquate de la lentille

Dans de rares cas, la lentille implantée peut se déplacer légèrement de sa position dans l'œil, mais plusieurs années après l'intervention. Cela peut entraîner des perturbations visuelles ou un éblouissement, qu'il peuvent généralement être corrigés par une intervention chirurgicale. Il arrive parfois que la puissance de la lentille ne corresponde pas parfaitement à l'œil, ce qui peut affecter la vision. Cela peut se produire si la lentille ne se positionne pas exactement comme prévu ou en raison de légères différences de calcul. Dans la plupart des cas, l'effet est mineur. Si l'cart est plus important, il peut généralement être corrigé par des lunettes, des lentilles de contact, une intervention LASIK ou une chirurgie.

Informez votre médecin si vous présentez :

- une douleur importante dans l'œil ;
- une rougeur récurrente de l'œil ;
- des maux de tête inhabituels ou des nausées ;
- une détérioration importante de la vision ;
- des éclairs lumineux ou une augmentation importante du nombre de corps flottants dans votre œil.

Il s'agit de complications rares pouvant survenir peu après l'intervention.

■ Infections et complications mineures

Comme pour toute intervention chirurgicale, il existe un faible risque d'infection après une chirurgie de la cataracte, bien que les complications graves soient rares. En cas d'infection, celle-ci peut généralement être traitée à l'aide de collyres prescrits. Vous devez contacter votre ophthalmologiste si votre œil devient écarlate ou si vous remarquez des symptômes inhabituels.

Certaines complications mineures peuvent inclure :

- un gonflement ;
- une augmentation de la pression intraoculaire ;
- une chute de la paupière.

Ces affections sont généralement temporaires et s'atténuent grâce aux médicaments et à une cicatrisation appropriée. Informez immédiatement votre ophthalmologiste si vous remarquez des changements afin que votre rétablissement puisse être surveillé et traité si nécessaire.

■ Opacification de la capsule postérieure

L'opacification de la capsule postérieure (OCP) est une affection fréquente qui peut survenir après une chirurgie de la cataracte. Elle se produit lorsque certaines cellules résiduelles du cristallin prolifèrent sur la fine membrane située derrière la lentille implantée, provoquant à nouveau une vision trouble. Bien qu'elle soit parfois appelée « cataracte secondaire », il ne s'agit pas d'une nouvelle cataracte.

Compatibilité avec la résonance magnétique

La LIO implantée ne contient aucun composant métallique et ne présente aucun risque d'interaction avec le champ de résonance magnétique (RM). La LIO est compatible avec l'imagerie par résonance magnétique (RM) réalisée à des intensités de champ magnétique de 1,5 et 3,0 Tesla.

Durée de vie attendue et suivi nécessaire

La LIO est généralement conçue pour durer toute la vie du patient. Toutefois, si vous constatez une détérioration de la qualité de votre vision, veuillez consulter votre ophthalmologiste afin de procéder à des examens complémentaires et à un traitement approprié. Votre ophthalmologiste discutera avec vous de la fréquence des consultations de suivi nécessaires en fonction de votre état de santé.

Déclaration des incidents graves

Tout incident grave survenant en lien avec la lentille intraoculaire doit être signalé à votre médecin (en premier lieu), au représentant local ou à EYEOL U.K. LIMITED.

À propos de ce document :

Votre ophthalmologiste a réalisé la chirurgie de la cataracte et a implanté les lentilles intraoculaires (LIO) dans votre œil. La carte d'implant du patient ainsi que cette notice vous ont été remises après l'intervention chirurgicale de la cataracte. Veuillez toujours conserver la carte d'implant du patient sur vous afin de faciliter la prise en charge médicale en cas d'urgence. Le lien indiqué sur la carte d'implant vous permettra d'accéder aux dernières mises à jour concernant la LIO.

Sie während des Eingriffs vollständig und. Sie sollten nur geringe oder keine Beschwerden verspüren. Ihr Augenarzt verwendet ein Mikroskop, um Ihr Auge vergrößert betrachten zu können. Ihre natürliche Linse befindet sich in einer sackartigen Struktur, die als LinsenkapSEL bezeichnet wird. Die LinsenkapSEL befindet sich direkt hinter dem farbigen Teil Ihres Auges (Iris). An der äußeren Oberfläche des Auges wird ein kleiner Schnitt vorgenommen. Durch diese Öffnung führt der Augenarzt eine winzige Sonde ein, um die eingebrütete Linse zu zerkleinern. Anschließend werden die Kataraktfragmente mit einem kleinen vakuumpumpierten Instrument aus dem Auge entfernt. Danach stellt ausreichend Platz zur Verfügung, um die Intraokularlinse in Ihr Auge einzusetzen und die zuvor entfernte natürliche Linse zu ersetzen. Ihr Arzt setzt die Intraokularlinse durch denselben kleinen Schnitt ein. Am Abschluss der Operation kann Ihr Augenarzt einen schützenden Verband oder eine Schutzschale über Ihr Auge legen.

Was Sie nach einer Kataraktoperation erwarten können

Unmittelbar nach der Operation sollten Sie für kurze Zeit im Aufwachbereich bleiben. Ihr Augenarzt sollte Ihnen eine Identifikationskarte (üblicherweise Implantatkarte genannt) aushändigen, die Sie in Ihrer Brieftasche aufbewahren sollten. Diese Karte enthält Angaben zum Typ des in Ihrem Auge eingesetzten Glases. Zeigen Sie diese Karte jedem Augenarzt vor, der Ihre Augen nach der Operation untersucht.

Viele Patienten bemerken bereits innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine Verbesserung ihres Sehvermögens. Bei einigen stabilisiert sich das Sehvermögen nach 10 bis 14 Tagen. Andere benötigen 4 bis 6 Wochen, um sich vollständig von der Operation zu erholen. Die Verbesserung des Sehvermögens ist von Person zu Person unterschiedlich.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Augenarzt, wenn nach der Operation Juckreiz, Schmerzen, Schwellen, „fliegende Mücken“ (Floaters), Rötungen, starke Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Lichtempfindlichkeit oder tränende Augen auftreten.

Anweisungen zur postoperativen Nachsorge

Sie können am selben Tag nach der Operation nach Hause zurückkehren. Ihr Augenarzt wird Ihnen Anweisungen zur Augenpflege und Medizin verschreiben, um die Heilung zu beschleunigen und Infektionen vorzubeugen. Nehmen Sie alle verordneten Medikamente ein und wenden Sie die Augentropfen gemäß den Anweisungen Ihres Augenarztes an.

Vermeiden Sie in der ersten Woche nach der Operation das Schwimmen sowie die Benutzung von Badekannen oder Whirlpools, um Infektionen vorzubeugen. Versuchen Sie außerdem, Ihr Auge vor Schutz, Staub und starkem Wind zu schützen. Tragen Sie möglichst häufig eine Sonnenbrille zum Schutz Ihrer Augen und verwenden Sie nachts die Augenschutzschale. Vermeiden Sie es, Ihr Auge zu reiben oder zusätzlichen Druck darauf auszuüben. Sie erhalten einen Termin für eine Nachuntersuchung, die in der Regel am nächsten Tag stattfindet. Je nach Heilungsverlauf wird Ihr Arzt Ihr Auge nach der Operation noch mehrere Male untersuchen. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich an die neue Intraokularlinse gewöhnt haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt, wenn Sie nach der Operation Fragen oder Bedenken haben.

Unwünschte Nebenwirkungen, Warnhinweise und Restrisiken

■ Visuelle Lichtphänomene

Nach einer Kataraktoperation können einige Patienten Blendungen oder Halos bemerken, insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen. Halos erscheinen als helle Ringe um Lichtquellen, während Blendungen als starker Licht wahrgenommen werden, das das klare Sehen beeinträchtigen kann. Diese Effekte können besonders beim nächtlichen Autofahren oder beim Blick auf künstliche Lichtquellen auftreten.

In den meisten Fällen verbessern sich diese Erscheinungen innerhalb weniger Wochen oder Monate, während sich das Gehirn an die Intraokularlinse anpasst. Sollten die Symptome nach Abschluss der Heilungsphase weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Augenarzt. Befolgen Sie stets die Anweisungen Ihres Chirurgen und melden Sie ungewöhnliche Symptome.

■ Dezentrierung oder abweichende Dioptrienstärke der Linse

In seltenen Fällen kann sich die implantierte Linse auch Jahre nach der Operation geringfügig aus ihrer Position im Auge verschieben. Dies kann Sehstörungen oder Blendungen verursachen, die in der Regel durch einen chirurgischen Eingriff korrigiert werden können. Manchmal entspricht die Linsenstärke nicht exakt den Anforderungen des Auges, was das Sehvermögen beeinträchtigen kann. Dies kann auftreten, wenn sich die Linse nicht genau wie vorhergesehen positioniert oder aufgrund kleiner Berechnungsabweichungen. In den meisten Fällen ist die Auswirkung gering. Bei größeren Abweichungen kann die Fehlsichtigkeit normalerweise mit einer Brille, Kontaktlinsen, LASIK oder einem chirurgischen Eingriff korrigiert werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Folgendes auftritt:

- starke Schmerzen im Auge
- wiederkehrende Augenrötungen
- ungewöhnliche Kopfschmerzen oder Übelkeit
- erhebliche Verschlechterung des Sehvermögens
- Lichtblitze oder eine starke Zunahme von „fliegenden Mücken“ (Floaters) im Auge

Dies sind seltene Komplikationen, die kurz nach der Operation auftreten können.

Infectionen und geringfügige Komplikationen

Wie bei jeder Operation besteht auch nach einer Kataraktoperation ein geringes Infektionsrisiko, obwohl schwerwiegende Komplikationen selten sind. Tritt eine Infektion auf, kann sie in der Regel mit verschriebenen Augentropfen behandelt werden. Sie sollten Ihren Augenarzt kontaktieren, wenn Ihr Auge anschwillt oder wenn Sie ungewöhnliche Symptome bemerken.

Zu den geringfügigen Komplikationen können gehören:

- Schwellungen
- erhöhter Augeninnendruck
- Herabhängendes Augenlid

Diese Zustände sind in der Regel vorübergehend und bessern sich durch Medikamente und einen normalen Heilungsverlauf. Informieren Sie Ihren Augenarzt unverzüglich, wenn Sie Veränderungen bemerken, damit Ihre Genesung überwacht und gegebenenfalls behandelt werden kann.

■ Nachstar (Posterior Capsule Opacification, PCO)

Der Nachstar (Posterior Capsule Opacification, PCO) ist eine häufige Erscheinung, die nach einer Kataraktoperation auftreten kann. Er entsteht, wenn verbliebene Linsenzellen auf der dünnen Membran hinter der implantierten Linse wachsen und dadurch das Sehvermögen erneut trüben. Obwohl dies manchmal als „sekundärer Katarakt“ bezeichnet wird, handelt es sich nicht um einen neuen Katarakt.

PCO kann einfach durch einen schnellen und schmerzfreien Nd:YAG-Lasereingriff behandelt werden, der von Ihrem Augenarzt durchgeführt wird. Die Behandlung dauert in der Regel nur wenige Minuten, und die meisten Patienten bemerken innerhalb eines Tages eine Verbesserung ihres Sehvermögens. Wenn Ihr Augenarzt nach der Operation erneut verschommen wird, wenden Sie sich für weitere Beratung an Ihren Augenarzt.

Magnetresonanz-Kompatibilität

Die implantierte Intraokularlinse enthält keine metallischen Bestandteile und ist sicher, da kein Risiko einer Wechselwirkung mit dem Magnetresonanzfeld (MR-Feld) besteht. Die Intraokularlinse ist für Magnetresonanztomographie (MRT) bei Magnetfeldstärken von 1,5 Tesla und 3,0 Tesla geeignet.

Erwartete Lebensdauer und erforderliche Nachsorge

Die Intraokularlinse hält in der Regel ein Leben lang. Sollten Sie jedoch eine Verschlechterung Ihrer Sehqualität feststellen, wenden Sie sich bitte zur weiteren Untersuchung und Behandlung an Ihren Augenarzt. Ihr Augenarzt wird mit Ihnen die erforderlichen Nachsorgeintervalle entsprechend Ihrer Gesundheitszustand besprechen.

Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit der Intraokularlinse sollte Ihrem Arzt (zunächst), dem örtlichen Vertreter oder EYEOL U.K. LIMITED gemeldet werden.

Über dieses Dokument

Ihr Augenarzt hat die Kataraktoperation durchgeführt und die Intraokularlinse (IOL) in Ihr Auge implantiert. Die Patienten-Implantatkarte und dieses Informationsblatt wurden Ihnen nach der Kataraktoperation ausgehändigt. Bitte führen Sie die Patienten-Implantatkarte stets mit sich, um im Notfall eine angemessene medizinische Versorgung zu erleichtern. Über den auf der Implantatkarte angegebenen Link erhalten Sie die neuesten Informationen zur Intraokularlinse.

 EYEOL U.K. LIMITED 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LUS 45B, Vereinigtes Königreich Tel: +44 (0) 1582 477 002 Fax: +44 (0) 1582 607 009 E-Mail: info@eyeol.co.uk Web: www.eyeol.co.uk	 Europäischer Bevollmächtigter OEBELIS S.A Bd. Général Wahnis, 53 1030 Bruxelles, Belgique Tel: +32.2.732.59.54 Fax: +32.2.732.60.03 Email: mail@oebelis.net Web: www.oebelis.net	 2460
--	--	---

Successivamente, utilizza un piccolo dispositivo simile a un aspiratore per rimuovere i frammenti di cataratta dall'occhio. A questo punto si crea lo spazio necessario per inserire la IOL nell'occhio e sostituire il cristallino naturale appena rimosso. Il medico inserirà la LIO attraverso la stessa piccola incisione. Al termine dell'intervento, l'oculista può applicare una medicazione protettiva o uno schermo protettivo sull'occhio.

Cosa aspettarsi dopo l'intervento di cataratta

Subito dopo l'intervento, dovete rimanere nell'area di recupero per un breve periodo. Il vostro oculista dovrebbe consegnarvi una scheda identificativa (generalmente chiamata scheda impianto) da conservare nel portafoglio. Questa scheda indica il tipo di impianto presente nel vostro occhio. Mostrate questa scheda a qualsiasi oculista che esami i vostri occhi dopo la chirurgia. Il vostro oculista vi darà anche una copia di questa scheda. Molti pazienti iniziano a vedere meglio entro 1 o 2 giorni. In alcuni casi la vista si stabilizza entro 10-14 giorni. Altri pazienti possono impiegare da 4 a 6 settimane per recuperare completamente dall'intervento. Il miglioramento della vista varia da persona a persona. Contattate immediatamente il vostro oculista se dopo l'intervento avvertite prurito, dolore, lampi di luce, "corpi mobili" (floaters), arrossamento, forte mal di testa, nausea/vomito, sensibilità alla luce o lacrimazione eccessiva.

Istruzioni per le cure post-operatorie

Potrete tornare a casa lo stesso giorno dell'intervento. Il vostro oculista vi prescriverà colliri antibiotici e farmaci per accelerare la guarigione e prevenire le infezioni. Assumete tutti i farmaci prescritti e applicate i colliri secondo le indicazioni del vostro oculista.

Durante la prima settimana dopo l'intervento, evitate di nuotare e di utilizzare vasche da bagno o idromassaggi per contribuire a prevenire le infezioni. Cercate inoltre di proteggere l'occhio da sporcizia, polvere e vento forte. Proteggetevi gli occhi il più possibile con occhiali da sole e dormite con la protezione oculare durante la notte. Evitate di strofinare l'occhio o di esercitare pressione su di esso. Vi verrà fornita una visita di controllo, generalmente il giorno successivo all'intervento. Il medico vi visiterà più volte dopo l'operazione in base alla velocità di guarigione. Potrebbe essere necessario un po' di tempo per abituarvi alla nuova IOL.

Parlate con il vostro oculista se avete domande o dubbi dopo l'intervento.

Effetti indesiderati, avvertenze e rischi residui

Fenomeni luminosi visivi

Dopo l'intervento di cataratta, alcuni pazienti possono notare abbagliamento o aloni, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Gli aloni appaiono come anelli luminosi attorno alle fonti di luce, mentre l'abbagliamento si manifesta come una luce intensa che può compromettere la visione nitida. Questi effetti possono essere più evidenti durante la guida notturna o osservando luci artificiali.

Nella maggior parte dei casi, tali effetti migliorano otto poche settimane o mesi, ma mano che il cervello si adatta alla lente intraoculare. Se persistono dopo la guarigione, consultate il vostro oculista. Seguite sempre le istruzioni del chirurgo e segnalate qualsiasi sintomo insolito.

Decentramento o potere diottrico non corretto della lente

In rari casi, la lente implantata può spostarsi leggermente dalla sua posizione all'interno dell'occhio, anche anni dopo l'intervento. Questo può causare disturbi visivi o abbagliamento, che generalmente possono essere corretti mediante una procedura chirurgica.

A volte il potere della lente potrebbe non corrispondere perfettamente all'occhio, il che può influenzare la visione. Questo può accadere se la lente non si posiziona esattamente come previsto o a causa di piccole differenze nei calcoli. Nella maggior parte dei casi, l'effetto è minimo. Se la differenza è maggiore, può generalmente essere corretta con occhiali, lenti a contatto, LASIK o un intervento chirurgico.

Informate il vostro medico se manifestate:

- forte dolore all'occhio
- arrossamento ricorrente dell'occhio
- aumento della pressione intraoculare
- notevole peggioramento della vista
- lampi di luce o un marcato aumento dei corpi mobili (floaters) nell'occhio

Queste sono complicanze rare che possono verificarsi poco dopo l'intervento chirurgico.

Infezioni e complicanze minori

Come per qualsiasi intervento chirurgico, esiste un piccolo rischio di infezione dopo l'intervento di cataratta, sebbene le complicanze gravi siano rare. Se si verifica un'infezione, di solito può essere trattata con colliri prescritti dal medico. Dovreste contattare il vostro oculista se l'occhio si gonfia o se notate sintomi insolit.

Alcune complicanze minori possono includere:

- Gonfiore
- Aumento della pressione intraoculare
- Abbassamento della palpebra
- Notevole peggioramento della vista

Queste condizioni sono generalmente temporanee e migliorano con la terapia farmacologica e una corretta guarigione. Informate immediatamente il vostro oculista se notate qualsiasi cambiamento, in modo che il recupero possa essere monitorato e trattato se necessario.

Opacizzazione della capsula posteriore

L'opacizzazione della capsula posteriore (PCO) è una condizione comune che può verificarsi dopo l'intervento di cataratta. Si verifica quando alcune cellule residue del cristallino crescono sulla sottile membrana situata dietro la lente implantata, causando nuovamente un annebbiamento della vista. Sebbene venga talvolta chiamata "cataratta secondaria", non si tratta di una nuova cataratta.

La PCO può essere facilmente trattata mediante una procedura laser ND-YAG rapida e indolore eseguita dal vostro oculista. Il trattamento richiede generalmente solo pochi minuti e la maggior parte dei pazienti nota un miglioramento della vista entro un giorno. Se la vostra vista torna ad essere sfocata dopo l'intervento, contattate il vostro oculista per ulteriori consigli.

Compatibilità con la Risonanza Magnetica

La IOL implantata non contiene componenti metallici ed è sicura, senza alcun potenziale di interazione con il campo di Risonanza Magnetica (RM). La LIO è sicura per l'esecuzione di esami di Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) con intensità di campo magnetico di 1,5 Tesla e 3,0 Tesla.

Durata prevista e follow-up necessari

La LIO generalmente dura per tutta la vita del paziente. Tuttavia, qualora dovete riscontrare un peggioramento della qualità della vista, consultate il vostro oculista per ulteriori accertamenti e trattamenti. Il vostro oculista discuterà con voi la frequenza dei controlli necessari in base alle vostre condizioni cliniche.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione alla lente intraoculare deve essere segnalato al proprio medico (in prima istanza), al rappresentante locale o a EYEOL U.K. LIMITED.